

Thème 15 : La santé publique

Introduction générale

Définition générale du thème

La **santé publique** se définit classiquement, selon la formule historique de Charles-Edward Amory Winslow reprise par l'**Organisation mondiale de la Santé**, comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé physique et mentale des individus par le biais d'efforts collectifs organisés. Contrairement à la médecine clinique traditionnelle, qui concentre son action sur l'approche curative et individualisée du patient, la santé publique appréhende la collectivité dans sa globalité. Elle déploie une approche holistique combinant l'épidémiologie, la salubrité environnementale, la prophylaxie, la planification sanitaire, la promotion des comportements sains et la gestion des systèmes de soins. En droit public et en science administrative, elle incarne une composante régalienne de l'action de l'État, matérialisée par la mise en œuvre de politiques publiques destinées à garantir la sécurité sanitaire de la population en tant que bien public.

Origine historique du concept

Les fondements de la santé publique remontent aux premières formes d'organisation sociale soucieuses de préserver la force vive du groupe. Dans l'Antiquité, les civilisations égyptienne, romaine et grecque manifestent une compréhension empirique de l'hygiène collective à travers l'édification d'aqueducs, de systèmes d'évacuation des eaux usées et l'instauration de règles de salubrité publique. Au Moyen Âge, la confrontation face aux grandes vagues épidémiques, notamment la peste noire de 1347, force les cités-États européennes à concevoir des instruments juridiques de coercition sanitaire, donnant naissance aux premiers concepts de **quarantaine**, de cordons sanitaires et d'enregistrement des causes de décès.

Évolution du concept dans le temps

Le basculement vers une approche moderne et scientifique de la santé publique s'opère au XIXe siècle à la faveur de la révolution industrielle. L'urbanisation massive et insalubre suscite l'émergence du mouvement "hygiéniste" porté en Europe par des figures comme Edwin Chadwick ou Louis René Villermé, établissant un lien de causalité structurel entre la pauvreté, les conditions de travail et la mortalité. Les découvertes bactériologiques de Louis Pasteur et Robert Koch confèrent à la discipline une base scientifique indiscutable, déplaçant l'action publique vers la vaccination obligatoire, la désinfection et la potabilisation de l'eau. Au XXe siècle, la création de l'Organisation mondiale de la Santé en 1948 formalise l'internationalisation des politiques sanitaires, tandis que la Conférence d'Alma-Ata en 1978 consacre le paradigme des **soins de santé primaires** comme pilier de l'équité sociale.

Importance contemporaine

À l'ère de la mondialisation, la santé publique se situe au carrefour d'enjeux systémiques globaux. La survenue de la pandémie de Covid-19 a rappelé de manière brutale l'extrême vulnérabilité des structures étatiques et la porosité des frontières face aux menaces pathogènes émergentes.

Parallèlement, le monde contemporain fait face à une transition épidémiologique complexe, marquée par le double fardeau des maladies infectieuses persistantes et l'explosion des **maladies non transmissibles** telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les cancers. Les dérèglements climatiques, l'insécurité sédentaire et la résistance aux antimicrobiens accentuent la nécessité d'une gouvernance sanitaire globale et interconnectée.

Intérêt pour les concours administratifs

Pour un candidat aux concours de la haute fonction publique sénégalaise, la maîtrise des concepts de santé publique s'avère indispensable pour appréhender les dynamiques de l'aménagement du territoire, de l'évaluation macroéconomique et de la justice sociale. La gestion du système de santé met en jeu les capacités d'arbitrage budgétaire de l'État, l'efficacité de la décentralisation et la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique hospitalière. Le droit à la santé, constitutionnellement garanti au Sénégal, interroge directement la responsabilité administrative, la légalité des mesures de police sanitaire et la capacité de l'État à assurer la continuité du service public face aux crises exceptionnelles.

Problématique générale

Dans quelle mesure l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Sénégal, oscillent-elles entre l'impératif républicain d'assurer l'équité d'accès aux soins et la contrainte structurelle de financer un système résilient face aux urgences sanitaires globales ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans une première partie les fondements théoriques et conceptuels qui encadrent la santé publique. Ensuite, nous procéderons à une analyse approfondie des dimensions politiques, juridiques et économiques des systèmes de santé. La troisième partie sera consacrée à l'examen des enjeux contemporains aux échelles nationale, africaine et internationale. Enfin, une quatrième partie mettra en lumière l'analyse critique du modèle sanitaire, ses forces, ses limites ainsi que ses perspectives d'avenir.

Première partie : Fondements théoriques et conceptuels

Définitions fondamentales

Définitions doctrinales

La doctrine de la santé publique s'articule autour du concept fondamental de **déterminants de la santé**, théorisés notamment par Marc Lalonde et approfondis par l'école de sociologie médicale. Ces déterminants englobent l'ensemble des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. La doctrine distingue également les trois niveaux de prévention. La prévention primaire vise à diminuer l'incidence d'une maladie en amont de son apparition par l'éducation à la santé et la vaccination. La prévention secondaire s'attache à déceler précocement la maladie pour en modifier l'évolution par le biais de dépistages systématiques. La prévention tertiaire intervient pour réduire les complications et favoriser la réadaptation des patients.

Définitions juridiques

Sur le plan juridique, la santé publique s'organise autour de la notion de **droit à la santé**, consacré par les grands textes internationaux et nationaux. Ce concept impose aux États une obligation de moyens consistant à garantir l'existence d'infrastructures sanitaires suffisantes, accessibles, acceptables et de bonne qualité. En droit public sénégalais, le Code de la santé publique et les textes subséquents définissent le cadre normatif des obligations de déclaration des maladies transmissibles, les règles d'hygiène collective, les prérogatives de la police sanitaire et le régime de responsabilité applicable aux établissements de soins.

Définitions institutionnelles

D'un point de vue institutionnel, la santé publique est le produit de l'action coordonnée des administrations centrales, des agences de régulation et des collectivités territoriales. Elle se matérialise par le concept de **gouvernance sanitaire**, qui désigne les processus de décision, de financement et de contrôle permettant d'orienter le système de soins. Au niveau macro-institutionnel, elle repose sur l'articulation entre le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, les directions régionales de la santé et les districts sanitaires, qui constituent les unités opérationnelles de base du système de santé.

Origines historiques

Antiquité

Durant l'Antiquité, la perception de la santé demeure largement dominée par des conceptions magico-religieuses, bien que des avancées rationnelles majeures émergent. Hippocrate, à travers son traité *Des airs, des eaux et des lieux*, pose les jalons de l'approche environnementale en liant la maladie aux facteurs géographiques et climatiques, rompant avec le fatalisme divin. L'Empire romain formalise la dimension administrative de la santé publique en créant un corps de médecins publics et en investissant massivement dans des infrastructures de salubrité, comprenant des thermes, des égouts et des réseaux d'aqueducs permettant de préserver la salubrité urbaine.

Époque moderne

L'Époque moderne est marquée par la conceptualisation de la "police de la santé" ou *Medizinische Polizey*, théorisée en Allemagne par Johann Peter Frank au XVIII^e siècle. Ce courant de pensée postule que l'État absolutiste a le devoir et l'intérêt démographique de veiller à la santé de ses sujets pour maximiser sa puissance économique et militaire. C'est également l'époque des premières collectes systématiques de données démographiques par John Graunt en Angleterre, qui jette les bases de la biostatistique et de la démographie sanitaire, outils indispensables à l'anticipation des crises épidémiques.

Époque contemporaine

Le XIX^e siècle consacre la révolution de l'hygiénisme et la découverte de l'origine hydrique du choléra par John Snow à Londres en 1854, événement fondateur de l'**épidémiologie** moderne. Le XX^e siècle voit l'institutionnalisation des systèmes de protection sociale universelle, notamment à travers le modèle de Lord Beveridge en Angleterre en 1942, fondant l'accès aux soins sur la citoyenneté et le financement par l'impôt, et le modèle bismarckien fondé sur les cotisations professionnelles. Ces modèles consacrent l'inscription de la santé publique au cœur de l'État-providence.

Évolutions récentes

Les dernières décennies du XX^e siècle et le début du XXI^e siècle voient l'émergence du concept de **sécurité sanitaire globale**, né de la prise de conscience de l'interconnexion des risques dans un

monde globalisé. Les crises successives du VIH, du SRAS, d'Ebola en Afrique de l'Ouest et de la Covid-19 ont redéfini la santé publique autour des capacités de détection précoce, de notification internationale obligatoire et de résilience des systèmes logistiques face à des ruptures d'approvisionnement mondiales.

Théories et courants de pensée

Aristote et Platon

Dans la pensée philosophique grecque, la santé participe de la vertu républicaine et de l'harmonie de la Cité. Platon, dans *La République*, envisage la médecine sous un angle utilitariste et eugéniste, affirmant que le médecin doit soigner les citoyens dont le corps est sain, mais laisser mourir ceux dont la constitution est irrémédiablement compromise afin de ne pas peser sur les finances collectives. Aristote adopte une démarche plus équilibrée, considérant la santé comme une condition sine qua non de l'exercice de la citoyenneté et du bonheur, la responsabilité de la cité étant d'assurer les conditions matérielles nécessaires à son maintien.

Thomas Hobbes

Pour Thomas Hobbes, l'instauration du Léviathan est motivée par la peur de la mort violente et la recherche de la sécurité individuelle. Dans cette perspective contractualiste, l'État souverain détient la responsabilité absolue de préserver la vie de ses sujets. La santé publique, en tant que rempart contre la destruction physique par la maladie ou l'épidémie, s'inscrit pleinement dans la mission originelle de protection contractuelle qui légitime l'autorité absolue de l'État.

John Locke

John Locke inscrit la préservation de la vie, de la liberté et de la propriété au rang des droits naturels inaliénables de l'homme. La mission du gouvernement civil est de garantir ces droits contre l'arbitraire. Par conséquent, les théories libérales découlant de Locke légitiment l'action de l'État en matière de santé publique dès lors qu'elle vise à protéger les individus contre les agressions extérieures, y compris les nuisances environnementales et les maladies transmissibles qui portent atteinte au droit naturel à la vie.

Montesquieu

Montesquieu, dans *De l'esprit des lois*, aborde de manière visionnaire les devoirs de l'État envers les indigents et les malades. Il affirme qu'un État a l'obligation d'assurer à tous les citoyens une subsistance assurée, une nourriture convenable, un vêtement approprié et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé. Il pose ainsi les fondements philosophiques de l'assistance publique et de la responsabilité de la puissance publique dans la prise en charge des pathologies liées à la précarité.

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau attribue la dégradation de la santé humaine aux artifices et aux inégalités de la société civile. Dans le *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, il soutient que la plupart de nos maux sont notre propre ouvrage et que nous les aurions presque tous évités en conservant la manière de vivre simple et solitaire qui nous était prescrite par la nature. La perspective rousseauiste innervait les courants contemporains de la promotion de la santé, qui mettent l'accent sur la transformation des environnements sociaux délétères plutôt que sur la seule technicité médicale.

Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville, analysant la démocratie américaine, s'inquiète du développement potentiel d'un "despotisme doux" où l'État se chargerait souverainement d'assurer la sécurité et le bien-être matériel des individus en échange de leur liberté politique. Appliqué à la santé publique, ce regard critique alerte contre les dérives hygiénistes où l'État, sous couvert de protection sanitaire et de promotion des comportements sains, s'immisce de manière intrusive dans la sphère privée et les libertés individuelles des citoyens.

Max Weber

Max Weber apporte un éclairage crucial à travers sa théorie de la **bureaucratisation** et de la rationalisation de l'action publique. Le système de santé moderne, avec ses protocoles standardisés, ses grilles budgétaires, ses agences de régulation et son organisation pyramidale, illustre parfaitement la domination rationnelle-légale. Weber permet d'analyser le risque de déshumanisation des soins et la technocratisation des décisions de santé publique, parfois déconnectées des réalités vécues par les usagers du service public.

Karl Marx

La pensée marxiste appréhende la santé publique comme un champ de bataille idéologique et économique déterminé par les rapports de production. Pour Karl Marx et Friedrich Engels, la mauvaise santé de la classe ouvrière est le produit direct de l'exploitation capitaliste, les conditions de travail insalubres et la malnutrition étant inhérentes à la maximisation de la plus-value. Dans cette optique, l'amélioration réelle de la santé de la population requiert une transformation radicale des structures économiques, le système de santé bourgeois tendant à traiter les symptômes plutôt qu'à éradiquer les causes structurelles des inégalités sociales de santé.

Deuxième partie : Analyse approfondie du thème

Les mécanismes de fonctionnement et principes fondamentaux

Le fonctionnement de la santé publique repose sur le principe de la **séparation des fonctions** entre la surveillance épidémiologique, la gestion des risques et la communication. La surveillance s'appuie sur des réseaux de notification obligatoire qui permettent de cartographier en temps réel l'incidence des pathologies. Le second principe cardinal est celui de la **territorialisation des politiques de santé**, qui postule que l'offre de soins doit être planifiée en fonction des spécificités démographiques et épidémiologiques de chaque aire géographique, évitant ainsi les déserts médicaux et la saturation des infrastructures de recours.

Les dimensions politiques

La santé publique est un instrument de légitimation politique pour les gouvernants. La capacité d'un régime à réduire la mortalité maternelle et infantile, à éradiquer une endémie ou à assurer une couverture vaccinale élevée constitue un indicateur majeur de performance démocratique. Néanmoins, la dimension politique s'exprime également dans les arbitrages conflictuels entre l'exigence de protection de la population et le respect des libertés publiques. L'adoption de mesures coercitives telles que le confinement, le couvre-feu sanitaire ou l'obligation vaccinale illustre la tension permanente entre la souveraineté de l'État en matière de police sanitaire et l'exercice des libertés constitutionnelles individuelles.

Les dimensions juridiques

Le cadre juridique de la santé publique est caractérisé par l'extension constante du **droit international de la santé**, sous l'égide du Règlement Sanitaire International. Au niveau interne, le droit public de la santé organise les compétences de la puissance publique en matière de contrôle des médicaments, de sécurité alimentaire et de régulation des professions médicales. Un enjeu juridique contemporain réside dans la judiciarisation de la santé publique, marquée par l'émergence de recours en responsabilité contre l'État pour carence fautive dans la gestion des crises sanitaires ou pour défaut de contrôle des produits défectueux commercialisés sur le territoire national.

Les dimensions économiques

Sur le plan économique, la santé publique est appréhendée sous l'angle de l'**économie de la santé**, discipline qui analyse l'allocation des ressources rares au sein du système de soins. La santé constitue un capital humain indispensable à la productivité économique globale d'une nation. Toutefois, le financement du système pose le défi du modèle économique : les mécanismes de tiers-payant et d'assurance maladie obligatoire visent à solvabiliser la demande de soins et à protéger les ménages contre les dépenses catastrophiques de santé. L'analyse critique montre que le coût croissant des innovations thérapeutiques et l'inflation médicale contraignent les États à mettre en œuvre des politiques d'efficience budgétaire drastiques, au risque de rationner l'accès aux traitements innovants.

Les dimensions sociales

Les **inégalités sociales de santé** constituent le défi sociologique majeur de la santé publique. L'espérance de vie et la prévalence des maladies restent fortement corrélées au niveau d'instruction, à la catégorie socioprofessionnelle et au milieu de vie. La santé publique doit intégrer la dimension culturelle des représentations de la maladie. Dans de nombreuses sociétés, le recours aux soins biomédicaux se confronte à la persistance des médecines traditionnelles et aux barrières linguistiques ou religieuses. Une politique de santé publique efficace implique donc une démarche d'anthropologie médicale pour assurer l'acceptabilité sociale des interventions de prévention.

Les dimensions administratives

L'administration de la santé publique se caractérise par une organisation pyramidale et déconcentrée. Le ministère sectoriel définit les orientations stratégiques, tandis que les agences d'exécution et les directions régionales assurent l'implémentation opérationnelle. Le management public de la santé fait face au défi de la coordination intersectorielle, la santé publique dépendant étroitement des administrations chargées de l'assainissement, de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement, suivant l'approche intégrée dite "**Une seule santé**" (*One Health*). La bureaucratisation excessive de l'administration sanitaire est fréquemment critiquée pour sa lenteur décisionnelle lors de la survenue de crises d'urgence.

Troisième partie : Enjeux contemporains

Enjeux nationaux : Le cas du Sénégal

Contexte épidémiologique et démographique

Le Sénégal se trouve au cœur d'une **transition épidémiologique** inachevée. Si le pays a enregistré des succès notables dans le contrôle de maladies transmissibles comme le paludisme, la tuberculose et le

VIH, il subit une augmentation exponentielle des maladies non transmissibles. L'urbanisation rapide, les modifications des habitudes alimentaires et la sédentarité alimentent une prévalence inquiétante de l'hygiène cardiovasculaire, du diabète et des affections oncologiques. Sur le plan démographique, la structure de la population reste caractérisée par sa jeunesse, ce qui implique des besoins immenses en matière de santé de la reproduction, tandis que l'allongement progressif de l'espérance de vie pose les prémices du défi de la gériatrie.

Politiques publiques et réformes institutionnelles

Pour structurer sa réponse, l'État du Sénégal a inscrit l'axe d'amélioration du capital humain au centre du Plan Sénégal Émergent. La mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire et Social s'articule avec le déploiement de la **Couverture Maladie Universelle**, devenue l'Agence nationale de la Couverture Sanitaire Universelle. Cette politique publique majeure vise à étendre la protection financière contre le risque maladie aux secteurs informel et rural par le biais des mutuelles de santé communautaires. Par ailleurs, des initiatives de gratuité ciblant la césarienne, la dialyse, les soins des enfants de moins de cinq ans et la gratuité des soins pour les personnes âgées via le Plan Sésame ont été instaurées pour lever la barrière financière d'accès aux soins.

Plan Sénégal Émergent (Axe Capital Humain)

- Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS)
- Agence Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle (ACSU)
- Politiques de Gratuités (Césarienne, Dialyse, Moins de 5 ans, Plan Sésame)

Institutions et infrastructures

L'architecture sanitaire sénégalaise repose sur une pyramide à trois niveaux : le niveau périphérique composé des cases de santé, postes de santé et centres de santé gérés à l'échelle des districts ; le niveau intermédiaire structuré autour des centres hospitaliers régionaux ; et le niveau central comprenant les centres hospitaliers universitaires de recours national situés principalement à Dakar. La régulation du secteur pharmaceutique a été profondément réformée avec la création de l'**Agence sénégalaise de Régulation pharmaceutique** et la modernisation de la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement, visant à sécuriser la chaîne de valeur du médicament et à lutter contre le marché illicite des faux médicaments.

Résultats et défis persistants

Les réformes ont permis d'obtenir des avancées indiscutables, notamment la réduction substantielle du taux de mortalité infanto-juvénile et l'augmentation du taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié. Toutefois, le système demeure confronté à de profonds déséquilibres géographiques. La région de Dakar concentre la majeure partie des médecins spécialistes, des infrastructures lourdes de radiothérapie ou d'imagerie, et des budgets hospitaliers, au détriment des régions de l'intérieur, notamment l'est et le sud du pays. Le financement de la Couverture Maladie Universelle souffre de tensions de trésorerie récurrentes, entraînant des retards de remboursement des structures de soins et fragilisant l'effectivité des gratuités proclamées.

Enjeux africains

Union Africaine et Centres africains de contrôle et de prévention des maladies

À l'échelle continentale, la gouvernance de la santé publique a franchi une étape historique avec l'autonomisation institutionnelle d'Africa CDC, l'agence de santé publique de l'Union Africaine. Cette

institution joue un rôle moteur dans l'harmonisation des politiques de préparation aux épidémies, la mise en commun des données épidémiologiques et le renforcement des capacités de laboratoire des États membres. L'Union Africaine s'attache également à matérialiser la Déclaration d'Abuja de 2001, par laquelle les chefs d'État s'étaient engagés à consacrer au moins 15 % de leur budget annuel au secteur de la santé, un objectif que seule une minorité de pays est parvenue à atteindre de manière pérenne.

CEDEAO et Organisation Ouest-Africaine de la Santé

Au niveau de la sous-région, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, institution spécialisée de la CEDEAO basée à Bobo-Dioulasso, coordonne la lutte contre les grandes endémies transfrontalières. L'OOAS a démontré son importance stratégique lors de l'épidémie de fièvre à virus Ebola en favorisant le déploiement de personnels médicaux solidaires et en standardisant les protocoles de contrôle aux frontières. L'enjeu majeur de l'OOAS réside actuellement dans l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques pour encourager l'émergence d'une industrie locale de production de vaccins et de médicaments essentiels, l'espace CEDEAO dépendant à plus de 80 % des importations extérieures.

L'UEMOA et la convergence des politiques de santé

L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine intervient dans le secteur de la santé publique par le prisme de l'intégration économique et de la libre circulation des professionnels de la santé. L'UEMOA développe des programmes communs de lutte contre les faux médicaments, de mutualisation des systèmes d'information sanitaire et d'harmonisation des cursus de formation des médecins, pharmaciens et infirmiers. L'organisation s'investit également dans la mise en place de normes communes de sécurité sanitaire des aliments, facteur déterminant de la santé publique environnementale au sein du marché commun.

Enjeux internationaux

L'Organisation mondiale de la Santé

L'OMS demeure l'autorité directrice et coordonnatrice de la santé publique internationale. Elle définit les normes techniques, formule les lignes directrices fondées sur les preuves scientifiques et pilote la réponse aux urgences sanitaires de portée internationale. Néanmoins, la gouvernance de l'OMS fait face à des critiques intenses concernant sa dépendance excessive vis-à-vis des contributions volontaires fléchées par des fondations privées ou des États donateurs, ce qui restreint son autonomie stratégique. Le débat actuel se concentre sur l'adoption d'un **traité international sur les pandémies** destiné à contraindre juridiquement les États au partage transparent des données et à un accès équitable aux contre-mesures médicales.

Banque mondiale et FMI

Les institutions de Bretton Woods exercent une influence prépondérante sur l'économie politique de la santé publique dans les pays en développement. Les plans d'ajustement structurel des années 1980 et 1990, imposés par le FMI, ont été largement incriminés par les sociologues et économistes pour avoir forcé le désengagement financier de l'État du secteur social, entraînant l'instauration du mécanisme de recouvrement des coûts et l'effondrement des infrastructures sanitaires de base. Aujourd'hui, la Banque mondiale a infléchi sa doctrine, investissant massivement dans le financement basé sur la performance et soutenant les stratégies de renforcement des systèmes de santé au nom du développement du capital humain mondial.

L'Organisation mondiale du Commerce et la question des brevets

L'OMC est au cœur des enjeux de santé publique à travers l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cet accord protège par des brevets industriels stricts les innovations pharmaceutiques, garantissant l'exclusivité commerciale aux firmes transnationales et maintenant les prix des nouveaux traitements à des niveaux inaccessibles pour les budgets des États du Sud. Bien que la Déclaration de Doha de 2001 ait réaffirmé le droit d'utiliser les **licences obligatoires** pour raisons de santé publique, la mise en œuvre de ces flexibilités suscite des pressions diplomatiques et économiques intenses, limitant la souveraineté sanitaire des pays d'Afrique subsaharienne face aux géants de l'industrie pharmaceutique.

Quatrième partie : Analyse critique

Forces et avantages du modèle actuel

Le modèle de santé publique développé ces dernières décennies présente des forces structurelles indéniables. L'adoption généralisée de l'approche par district sanitaire a permis de rapprocher les services de soins de base des populations rurales et de rationaliser la gestion locale des ressources. Le Sénégal a prouvé la réactivité et l'expertise technique de ses équipes épidémiologiques lors de la gestion d'urgences complexes, saluée au niveau international lors de l'endiguement rapide de cas importés d'Ebola ou lors de la première phase de la pandémie de Covid-19 grâce à l'action opérationnelle de l'Institut Pasteur de Dakar et du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire. L'ancrage communautaire, matérialisé par le rôle des "badienou gokh" (marraines de quartier) et des relais communautaires, constitue un levier d'action social exceptionnel pour la promotion de la santé de la reproduction et de la vaccination de proximité.

Faiblesses et limites structurelles

Malgré ces acquis, le système de santé publique fait face à des limites systémiques profondes :

- **La précarité du financement public** : Le budget alloué à la santé reste en deçà des engagements internationaux, maintenant une dépendance structurelle forte vis-à-vis de l'aide publique au développement et des financements extérieurs verticaux dédiés à des maladies spécifiques.
- **Le niveau élevé des paiements directs par les ménages** : Les dépenses de santé à la charge directe des patients demeurent un facteur majeur d'appauvrissement et d'exclusion des soins pour les populations les plus vulnérables.
- **La crise des ressources humaines** : Le système souffre d'un déficit quantitatif d'infirmiers, de sages-femmes et de médecins spécialistes, aggravé par une fuite des cerveaux vers les pays du Nord et un refus fréquent d'affectation dans les zones rurales enclavées en raison du manque d'attractivité des conditions de vie et de travail.
- **La vétusté et le déficit de maintenance des équipements lourds** : Les pannes récurrentes d'appareils de radiothérapie, de scanners ou de centrales d'oxygène dans les hôpitaux publics illustrent les failles du management hospitalier et de la logistique publique.

Débats contemporains et controverses

Un des débats les plus vifs concerne la **place du secteur privé** dans le système de santé publique. Pour certains analystes, l'encouragement des partenariats public-privé et de la médecine libérale

permet de délester l'État d'investissements lourds et d'offrir une alternative de qualité aux classes moyennes. Pour les tenants d'une approche de service public stricte, cette dynamique favorise une dualisation du système de santé, caractérisée par une médecine d'élite performante pour les populations solvables et un service public sous-financé et dégradé pour les pauvres. Un autre débat concerne la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en cas de viol ou d'inceste, une question complexe où s'affrontent les arguments de santé publique liés à la mortalité par avortement clandestin et les convictions religieuses, éthiques et culturelles de la société.

Perspectives d'avenir

L'avenir de la santé publique s'articule autour de la transition vers la **souveraineté sanitaire et pharmaceutique**. L'ambition affichée par le Sénégal à travers le projet de production de vaccins contre la Covid-19 et d'autres pathologies endémiques à la nouvelle usine de Diamniadio préfigure un modèle d'autonomie industrielle indispensable pour s'affranchir de la dépendance géopolitique des marchés internationaux. Par ailleurs, la transformation numérique de la santé, par le biais de la télémédecine, de la digitalisation des dossiers médicaux et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la modélisation épidémiologique, offre des perspectives majeures pour surmonter le déficit d'expertise médicale dans les zones enclavées. Enfin, l'institutionnalisation d'un financement endogène durable, basé sur des taxes sur les produits néfastes pour la santé (tabac, alcool, boissons sucrées), pourrait sécuriser les budgets de la prévention et de la couverture sanitaire universelle.

Références académiques

Auteurs majeurs

- **Charles-Edward Amory Winslow** : Universitaire américain, auteur de la définition classique de la santé publique axée sur l'effort communautaire organisé.
- **Marc Lalonde** : Ancien ministre de la Santé du Canada, concepteur du rapport fondateur de 1974 qui a révolutionné la discipline en démontrant que la biologie humaine, l'environnement et les habitudes de vie ont un impact plus déterminant sur la santé que l'organisation du système de soins curatifs.
- **Amartya Sen** : Économiste, dont les travaux sur l'approche par les capacités démontrent que la santé est une liberté fondamentale qui conditionne toutes les autres opportunités de développement économique et individuel.
- **Didier Fassin** : Anthropologue et sociologue médical français, théoricien de la "biopolitique" contemporaine, qui étudie la manière dont les institutions étatiques évaluent et gèrent la valeur de la vie humaine à travers les politiques de santé publique.

Ouvrages essentiels

- *Rapport Lalonde : Nouvelle perspective de la santé des Canadiens* (1974) : Texte fondateur de la promotion de la santé moderne.
- *Un nouveau modèle économique* d'Amartya Sen (1999) : Analyse le rôle de la santé comme liberté réelle et intrant du développement.
- *L'Ombre de la maladie : Histoire de la santé publique en Afrique* (ouvrages collectifs d'histoire coloniale) : Analysent comment la médecine coloniale s'est structurée autour de la préservation de la force de travail et de la protection des enclaves européennes.

- *Rapports annuels sur la santé dans le monde* de l'OMS : Documents de référence pour l'analyse comparative des systèmes de soins et du financement de la couverture sanitaire.

Théories importantes

- **Théorie de la transition épidémiologique** (Abdel Omran, 1971) : Modélise le passage historique d'un régime de mortalité dominé par les maladies infectieuses et les famines vers un régime dominé par les maladies chroniques et dégénératives.
- **Le paradigme de la promotion de la santé** (Charte d'Ottawa, 1986) : Théorie politique et sanitaire qui vise à donner aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci en agissant sur les politiques publiques globales.

Concepts à maîtriser

- **Déterminants sociaux de la santé** : Facteurs économiques et sociaux influençant l'état sanitaire.
- **Sécurité sanitaire globale** : Cadre opérationnel de protection contre les menaces épidémiques mondiales.
- **One Health (Une seule santé)** : Approche intégrée reconnaissant l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale.
- **Dépenses catastrophiques de santé** : Seuil financier au-delà duquel le paiement direct des soins bascule un ménage dans la pauvreté.

Références juridiques et institutionnelles

Constitution du Sénégal

- **Article 8** : Garantit à tous les citoyens les libertés fondamentales économiques et sociales, y compris le droit à la santé.
- **Article 17** : Dispose que l'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de mettre en œuvre les politiques appropriées pour assurer l'accès aux soins de santé.

Lois pertinentes

- **Loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative au Code de la santé publique du Sénégal** : Texte de base fixant le régime juridique de l'hygiène, de la police sanitaire et de la lutte contre les épidémies.
- **Loi n° 2015-02 du 6 janvier 2015 relative aux mutuelles de santé** : Encadre l'organisation administrative et financière des groupements mutualistes supportant la Couverture Maladie Universelle.
- **Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales** (modifiée par le Code général des Collectivités territoriales de 2013) : Consacre le transfert de compétences en matière de santé et d'action sociale aux communes et départements.

Conventions internationales

- **Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (1946)** : Proclame dans son préambule que la santé est un droit fondamental de tout être humain sans distinction de race, de religion, d'opinion politique ou de condition économique.
- **Règlement Sanitaire International (RSI, 2005)** : Instrument juridique contraignant de l'OMS imposant aux États des capacités de surveillance et de notification obligatoire des urgences de santé publique de portée internationale.
- **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)** : Son article 16 consacre le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.